五项 ILD 研究文献元数据与证据入库报告

仅核验原始研究元数据与摘要。未下载受限全文、未完成完整偏倚风险或 GRADE 评级；本文不构成治疗建议。两个数据库索引同一论文，不是独立临床证据。

研究	年份	PMID	DOI
SENSCIS	2019	31112379	10.1056/NEJMoa1903076
INBUILD	2019	31566307	10.1056/NEJMoa1908681
TRAIL1	2023	36075242	10.1016/S2213-2600(22)00260-0
RELIEF	2021	33798455	10.1016/S2213-2600(20)30554-3
U-ILD	2020	31578169	10.1016/S2213-2600(19)30341-8

SENSCIS

题名：Nintedanib for Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease.

作者：Distler O 等；期刊：The New England journal of medicine；2019，380(26)，2518-2528。

PMID：31112379；DOI：10.1056/NEJMoa1903076。

原始链接：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31112379/；https://doi.org/10.1056/NEJMoa1903076

数据库研究类型：Journal Article；Multicenter Study；Randomized Controlled Trial；Research Support, Non-U.S. Gov't。本次仅原始论文摘要，非新闻公告或会议摘要。

查询式：SENSCIS[Title/Abstract] AND Distler[Author] AND 2019[Date - Publication]；候选数：3；按原始题名唯一匹配。

来源位置：PubmedArticle[MedlineCitation/PMID='31112379']/MedlineCitation/Article；源响应：raw/SENSCIS_pubmed.response；SHA-256：ce1f8f99356b422125723e9bfe4c72febbd05101541ba3c04104c971119bf02b；UTC 获取时间：2026-10-14T07:36:02.871229+00:00。

Europe PMC：同一 PMID/DOI/题名/年份及摘要数字集合核对通过（32 个数字 token）；不代表统计学复算。

样本量、完整纳排标准、主要终点模型和临床结论尚未在本元数据测试中进行专业提取，不从摘要关键词推断填写。

INBUILD

题名：Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases.

作者：Flaherty KR 等；期刊：The New England journal of medicine；2019，381(18)，1718-1727。

PMID：31566307；DOI：10.1056/NEJMoa1908681。

原始链接：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31566307/；https://doi.org/10.1056/NEJMoa1908681

数据库研究类型：Clinical Trial, Phase III；Journal Article；Multicenter Study；Randomized Controlled Trial；Research Support, Non-U.S. Gov't。本次仅原始论文摘要，非新闻公告或会议摘要。

查询式：nintedanib[Title] AND progressive[Title] AND fibrosing[Title] AND 2019[Date - Publication]；候选数：2；按原始题名唯一匹配。

来源位置：PubmedArticle[MedlineCitation/PMID='31566307']/MedlineCitation/Article；源响应：raw/INBUILD_pubmed.response；SHA-256：

be57dadc619da9f96db79cd51bccbc3c1c6e991de3538e9216f7e89b2c693588；UTC 获取时间：2026-10-14T07:36:05.964237+00:00。

Europe PMC：同一 PMID/DOI/题名/年份及摘要数字集合核对通过（27 个数字 token）；不代表统计学复算。

样本量、完整纳排标准、主要终点模型和临床结论尚未在本元数据测试中进行专业提取，不从摘要关键词推断填写。

TRAIL1

题名：Safety, tolerability, and efficacy of pirfenidone in patients with rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 study.

作者：Solomon JJ 等；期刊：The Lancet. Respiratory medicine；2023，11(1)，87-96。

PMID：36075242；DOI：10.1016/S2213-2600(22)00260-0。

原始链接：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36075242/；https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00260-0

数据库研究类型：Randomized Controlled Trial；Clinical Trial, Phase II；Journal Article；Research Support, Non-U.S. Gov't。本次仅原始论文摘要，非新闻公告或会议摘要。

查询式：pirfenidone[Title] AND rheumatoid[Title] AND randomised[Title]；候选数：1；按原始题名唯一匹配。

来源位置：PubmedArticle[MedlineCitation/PMID='36075242']/MedlineCitation/Article；源响应：raw/TRAIL1_pubmed.response；SHA-256：bd8d3de4d974fdda7201e47bf9dcc2e6b7476cecf865a1aeb15d1d4dc98937de；UTC 获取时间：2026-10-14T07:36:07.634825+00:00。

Europe PMC：同一 PMID/DOI/题名/年份及摘要数字集合核对通过（77 个数字 token）；不代表统计学复算。

样本量、完整纳排标准、主要终点模型和临床结论尚未在本元数据测试中进行专业提取，不从摘要关键词推断填写。

RELIEF

题名：Pirfenidone in patients with progressive fibrotic interstitial lung diseases other than idiopathic pulmonary fibrosis (RELIEF): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2b trial.

作者：Behr J 等；期刊：The Lancet. Respiratory medicine；2021，9(5)，476-486。

PMID：33798455；DOI：10.1016/S2213-2600(20)30554-3。

原始链接：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33798455/；https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30554-3

数据库研究类型：Journal Article；Multicenter Study；Randomized Controlled Trial；Research Support, Non-U.S. Gov't。本次仅原始论文摘要，非新闻公告或会议摘要。

查询式：RELIEF[Title] AND pirfenidone[Title]；候选数：2；按原始题名唯一匹配。

来源位置：PubmedArticle[MedlineCitation/PMID='33798455']/MedlineCitation/Article；源响应：raw/RELIEF_pubmed.response；SHA-256：3935568f51401b230ee1b0f67cb091c531d28424d06fefffea4bce43b2f76bbe；UTC 获取时间：2026-10-14T07:36:09.684096+00:00。

Europe PMC：同一 PMID/DOI/题名/年份及摘要数字集合核对通过（71 个数字 token）；不代表统计学复算。

样本量、完整纳排标准、主要终点模型和临床结论尚未在本元数据测试中进行专业提取，不从摘要关键词推断填写。

U-ILD

题名：Pirfenidone in patients with unclassifiable progressive fibrosing interstitial lung disease: a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial.

作者：Maher TM 等；期刊：The Lancet. Respiratory medicine；2020，8(2)，147-157。

PMID：31578169；DOI：10.1016/S2213-2600(19)30341-8。

原始链接：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31578169/；https://doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30341-8

数据库研究类型：Clinical Trial, Phase II；Journal Article；Multicenter Study；Randomized Controlled Trial；Research Support, Non-U.S. Gov't。本次仅原始论文摘要，非新闻公告或会议摘要。

查询式：pirfenidone[Title] AND unclassifiable[Title] AND placebo-controlled[Title] NOT design[Title]；候选数：1；按原始题名唯一匹配。

来源位置：PubmedArticle[MedlineCitation/PMID='31578169']/MedlineCitation/Article；源响应：raw/U-ILD_pubmed.response；SHA-256：4a0da7deb0b9431bcf5820d9568bff19fbf815c62669b548d15e238292037d2a；UTC 获取时间：2026-10-14T07:36:11.727271+00:00。

Europe PMC：同一 PMID/DOI/题名/年份及摘要数字集合核对通过（109 个数字 token）；不代表统计学复算。

样本量、完整纳排标准、主要终点模型和临床结论尚未在本元数据测试中进行专业提取，不从摘要关键词推断填写。

U-ILD 在本次测试中特指吡非尼酮用于未分类进展性纤维化 ILD 的 phase 2 原始研究，避免与其他未分类 ILD 研究混淆。